VIH — Fiche de révision

Virus de l'immunodéficience humaine

UE B1.3 S1 — Système immunitaire, pathologies infectieuses et inflammatoires. Cours du 27 octobre 2026 — Dre Laura Levi — Université Paris-Saclay.

L'idée centrale

Le VIH cible principalement les lymphocytes T CD4. Un traitement antirétroviral pris durablement contrôle la réplication, permet une vie proche de la normale et empêche la transmission sexuelle lorsque la charge virale est durablement indétectable : I = I.

Objectifs : distinguer VIH, immunodépression et sida ; identifier transmission, phases, infections opportunistes et complications ; interpréter charge virale et CD4 ; comprendre dépistage, antirétroviraux, PrEP et TPE ; adopter une posture infirmière non jugeante et un accompagnement global.

Priorités soulignées pendant le cours

VIH ≠ sida ; vulnérabilité autour de 200 CD4/mm³ ; I = I ; traitement dès que possible et à vie ; dépistage ; PrEP / TPE ; éducation thérapeutique et prise en charge globale. Les autres notions sont conservées pour leur intérêt pédagogique, sans inventer des consignes d'examen.

Sources : support officiel et explications de la séance, rapprochés des références HAS, EMA, ONUSIDA et Santé publique France pour les divergences signalées. Cette fiche ne remplace ni un protocole, ni une prescription.

Méthode : relier CD4 au risque opportuniste, puis charge virale à l'efficacité du traitement et à la transmission. Les tableaux accompagnent les explications ; le lexique termine la fiche.

01 Fondamentaux : VIH, rétrovirus, CD4 et sida

02 Transmission, prévention, données épidémiologiques

03 Histoire naturelle et manifestations cliniques

04 Infections opportunistes : reconnaître et comprendre

05 Complications, cancers et risque cardiovasculaire

06 Dépistage, biologie et suivi

07 Antirétroviraux : objectifs et observance

08 Prévention médicamenteuse : PrEP et PEP / TPE

09 Grossesse, partenaire et allaitement

10 Rôle infirmier et approche globale

11 Situations cliniques et raisonnement de soins

12 Synthèse générale — l'essentiel du cours

13 Pièges QCM / confusions à éviter

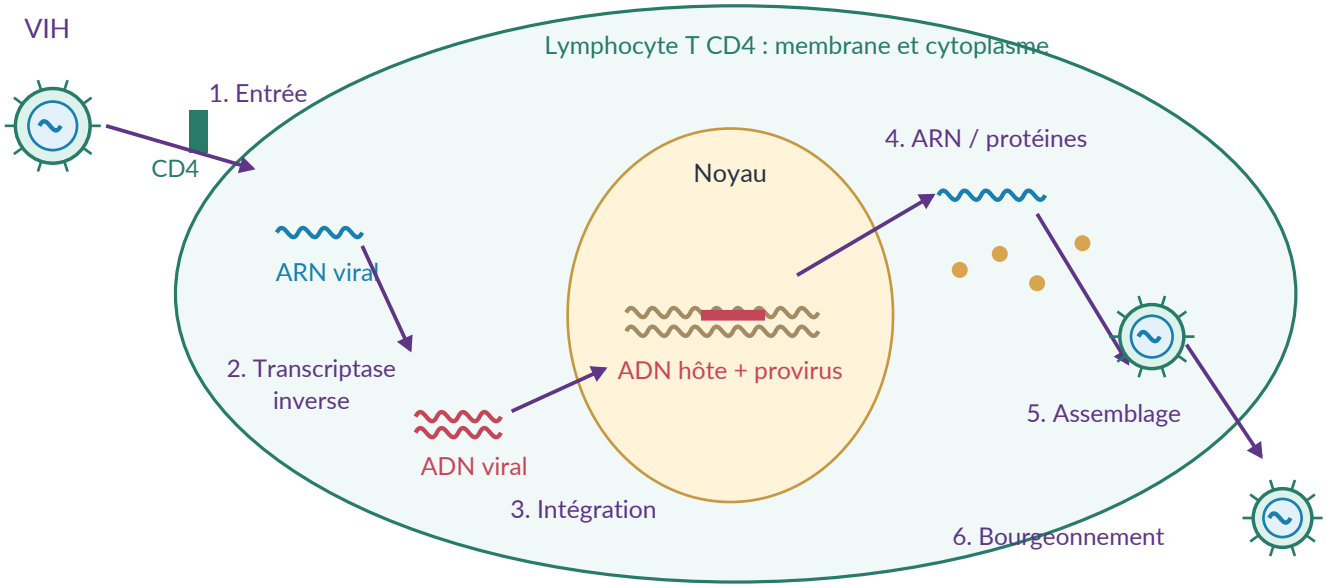
14 Définitions et mots-clés

01 Fondamentaux : VIH, rétrovirus, CD4 et sida

1.1. Le VIH est un rétrovirus persistant

Le VIH est le virus de l'immunodéficience humaine. Il a besoin de cellules de l'hôte pour se multiplier. Sa particularité, présentée pendant le cours, est la rétrotranscription de son ARN en ADN puis l'intégration de cet ADN dans le génome de cellules infectées. Cette intégration entretient des réservoirs viraux : supprimer l'ARN circulant ne signifie pas éliminer tous les virus persistants.

Du rétrovirus au réservoir intégré



Contrôler l'ARN circulant n'efface pas l'ADN intégré : le réservoir peut persister.

À RETENIR

On peut contrôler durablement le VIH par les antirétroviraux, mais pas considérer l'infection comme guérie dans les conditions habituelles. Les rares cas exceptionnels évoqués à l'oral ne constituent pas une stratégie de guérison courante.

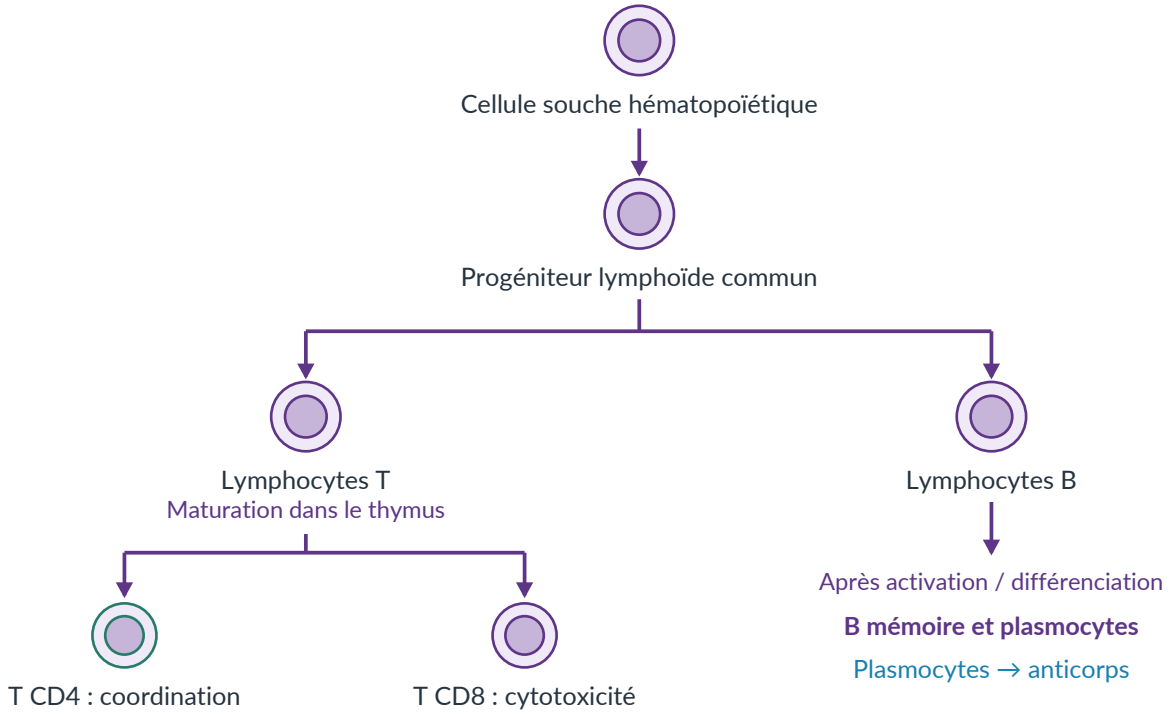
1.2. Deux marqueurs complémentaires

Marqueur	Ce qu'il mesure	Ce qu'il aide à comprendre
Charge virale VIH	ARN du VIH circulant, exprimé notamment en copies/mL.	Niveau de réplication, efficacité du traitement, risque de transmission.
Lymphocytes T CD4	Nombre de lymphocytes T CD4 par mm^3 de sang.	État des défenses immunitaires et vulnérabilité aux infections opportunistes.
ADN proviral	ADN du VIH intégré dans des cellules.	Persistance du réservoir viral, différente de la charge virale plasmatique.

1.3. Les T CD4 : chefs d'orchestre de l'immunité

Les lymphocytes T CD4 coordonnent des réponses immunitaires et participent à la protection contre les micro-organismes et les tumeurs. Ils sont une cible privilégiée du VIH et diminuent progressivement sans contrôle de la réplication. Ils ne sont ni une hormone ni un anticorps : ce sont des cellules immunitaires. Les lymphocytes B participent, eux, à la production d'anticorps ; les T CD8 exercent notamment des fonctions cytotoxiques.

Lignée lymphoïde : situer les T CD4



La séance utilise le repère < 200 CD4/mm³ pour identifier un risque accru d'infections opportunistes. Il ne faut toutefois pas transformer ce seuil en définition unique et automatique du sida : le stade sida est lié à des critères cliniques et immunologiques précis.

1.4. VIH et sida : deux termes à ne jamais confondre

Une personne vivant avec le VIH (PVVIH) peut être asymptomatique, traitée et ne pas être au stade sida. Le sida (syndrome d'immunodéficience acquise) correspond à un stade avancé de l'infection par le VIH, notamment révélé par certaines infections opportunistes ou maladies définissant ce stade. Une infection opportuniste peut aussi survenir dans d'autres immunodépressions, sans qu'on parle alors de sida.

MESSAGE EXPRESSÉMENT SOULIGNÉ

L'enseignante insiste : la majorité des PVVIH ne vivent pas avec un sida. Sous traitement efficace, elles peuvent retrouver une immunité satisfaisante et mener une vie proche de la normale ; l'arrêt du traitement expose à une remontée de la charge virale et à une baisse des CD4.

02 Transmission, prévention, données épidémiologiques

2.1. Voies de transmission

Voie	Explication dans le cours	Prévention / vigilance
Sexuelle	Principale voie de transmission évoquée en France ; exposition aux liquides sexuels infectants.	Préservatif, dépistage, PrEP et contrôle viral chez la PVVIH.
Sanguine	Partage de matériel d'injection ou exposition professionnelle au sang.	Précautions standard, matériel sécurisé, procédure AES, TPE selon évaluation.
Parent-enfant	Risque pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement selon le contexte.	Suivi spécialisé, contrôle durable de la charge virale et mesures adaptées.

Le contact social ordinaire, l'examen clinique et les interactions du quotidien ne sont pas des situations de transmission du VIH. Le personnel soignant applique les précautions standard à toutes les personnes, indépendamment d'un statut sérologique connu ou supposé.

2.2. Indétectable = intransmissible (I = I)

Lorsqu'une personne sous traitement a une charge virale durablement indétectable, le VIH n'est pas transmis par voie sexuelle. L'enseignante fait de ce message une priorité majeure de santé publique, à la fois pour prévenir la transmission et combattre la stigmatisation. La diapositive fixe un objectif biologique de < 50 copies/mL. Le résultat biologique et sa durabilité sont suivis médicalement.

> **NE PAS CONFONDRE**
>
> I = I concerne la transmission sexuelle dans les conditions de suppression virale durable ; cela ne dispense pas des précautions standard lors des soins exposant au sang ni du dépistage des autres IST.

2.3. Quelques repères de la séance — chiffres datés

Pour 2024, la fiche ONUSIDA 2025 estime 40,8 millions de personnes vivant avec le VIH, 1,3 million de nouvelles infections et 630 000 décès liés au sida. Le support affiche 1,5 million de nouvelles infections : cette valeur est corrigée ici. En France, les 180 000 PVVIH sont un chiffre attribué au support pour 2022 ; les quelque 5 000 découvertes de 2024 constituent un autre indicateur (5 100 selon Santé publique France). Une découverte de séropositivité n'est pas nécessairement une infection acquise cette même année.

L'épidémiologie française présentée comporte notamment des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), des personnes nées à l'étranger, des personnes trans, des travailleuses et travailleurs du sexe et des usagers de drogues injectables. Ces catégories servent à adapter l'accès au dépistage et à la prévention, jamais à présumer du statut d'une personne ou à la juger.

03 Histoire naturelle et manifestations cliniques

3.1. Trois phases schématiques, en l'absence de traitement

Phase	Charge virale / CD4	Manifestations possibles
Primo-infection	Pic initial de réplication virale, parfois baisse transitoire des CD4.	Souvent asymptomatique ou syndrome viral aigu.
Latence clinique	Contrôle immunitaire partiel, mais destruction progressive des CD4.	Longue période peu symptomatique possible, sans disparition du VIH.
Immunodépression avancée	CD4 très diminués, charge virale souvent élevée.	Infections opportunistes, atteintes tumorales, complications.

Sans traitement : deux marqueurs, deux lectures

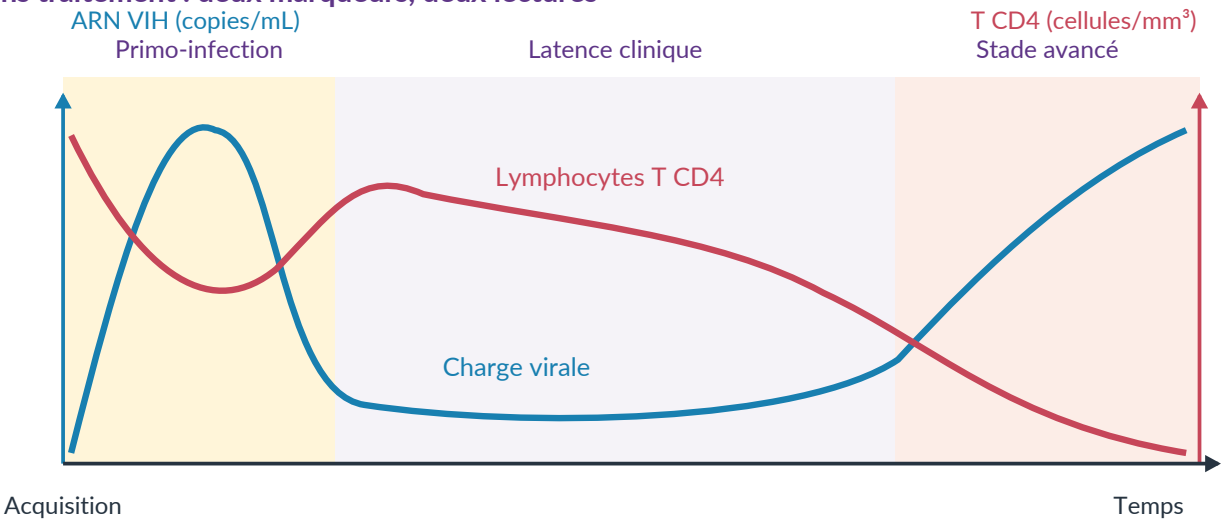


Schéma qualitatif : axes indépendants, sans valeurs ni durées prédictives.

Le risque opportuniste augmente notamment si CD4 < 200/mm³ ; le traitement modifie cette évolution.

3.2. Primo-infection : quoi rechercher ?

La séance situe les manifestations possibles environ 2 à 6 semaines après la contamination : fièvre, myalgies, céphalées, angine/pharyngite, éruption cutanéo-muqueuse, polyadénopathies. Elle évoque aussi cytolyse hépatique, syndrome mononucléosique et anomalies de l'hémogramme (lymphopénie, neutropénie, thrombopénie). Cette clinique est non spécifique : elle ne permet pas à elle seule de conclure à une infection VIH.

À RETENIR

Un tableau pseudo-grippal peut correspondre à une primo-infection, mais l'absence de symptômes n'exclut pas le VIH. En cas d'exposition, l'évaluation repose sur le contexte, les examens adaptés et la consultation.

3.3. Pourquoi apparaissent les infections opportunistes ?

En diminuant les CD4, le VIH réduit la capacité de l'organisme à contrôler certains micro-organismes. Les infections qui en résultent varient selon le degré d'immunodépression. Le cours souligne que la tuberculose peut survenir même avec des CD4 relativement conservés, alors que d'autres infections surviennent surtout lors de déficits plus profonds.

04 Infections opportunistes : reconnaître et comprendre

La liste de la séance comprend notamment pneumocystose, toxoplasmose, tuberculose, cryptococcose, cytomégalovirus (CMV), candidoses, leucoencéphalopathie multifocale progressive, cryptosporidiose, microsporidiose, zona et herpès. Le tableau ci-dessous développe les tableaux particulièrement expliqués par l'enseignante.

DEUX AXES DE TRAITEMENT AU STADE AVANCÉ

L'enseignante donne une double priorité devant une infection opportuniste : (1) traiter spécifiquement l'infection diagnostiquée et (2) contrôler le VIH par antirétroviraux pour permettre la remontée des CD4 et prévenir d'autres infections. Les modalités et le calendrier relèvent d'une décision médicale spécialisée.

Infection / agent	Présentation évocatrice	Prise en charge évoquée / vigilance
Tuberculose Mycobactérie	Altération de l'état général fébrile, atteinte pulmonaire ou extrapulmonaire (os, système nerveux, muscles).	Précautions Air en cas de tuberculose pulmonaire contagieuse ; traitement antituberculeux spécialisé, dépistage VIH associé.
Pneumocystose Champignon	Toux sèche, dyspnée, fièvre ; possibles formes graves avec détresse respiratoire.	Cotrimoxazole évoqué comme traitement et prévention ; parfois corticoïdes sur indication médicale. Prophylaxie lorsque CD4 bas, repère de cours < 200/mm³.
Toxoplasmose Parasite	Atteinte cérébrale : lésions/abcès, déficit neurologique focal, crises convulsives.	La diapositive cite le cotrimoxazole comme option thérapeutique ; traitement spécialisé sur prescription, sans conclure à un AVC sans bilan.
Cryptococcose Levure	Méningite, céphalées fébriles, hypertension intracrânienne ; possible abcès.	Diapositive : amphotéricine B et flucytosine ; parfois ponctions lombaires répétées. L'oral évoque des CD4 souvent très bas (repère < 50/mm³).
CMV Cytomégalovirus	Rétinite avec risque visuel, colite/diarrhées, plus rarement atteinte neurologique ou pulmonaire.	Le support cite ganciclovir par voie intraveineuse et valganciclovir par voie orale, sur prescription spécialisée.

TUBERCULOSE : PRIORITÉ DE SOINS

L'enseignante insiste sur deux points : penser à un dépistage VIH devant une tuberculose et appliquer les précautions Air adaptées lorsqu'une tuberculose pulmonaire contagieuse est suspectée ou confirmée. La tuberculose ne se gère pas comme une simple précaution « gouttelettes ».

Autres atteintes à connaître

• Candidoses : possibles atteintes muqueuses ou œsophagiennes en immunodépression.

• Zona / herpès : réactivations virales, possibles révélateurs d'une vulnérabilité immunitaire. Devant un zona évocateur dans son contexte, penser à évaluer l'immunité et à proposer un dépistage VIH adapté ; le zona ne suffit pas à diagnostiquer le VIH.

• Leucoencéphalopathie multifocale progressive : atteinte neurologique opportuniste évoquée dans la liste du cours.

• Cryptosporidiose et microsporidiose : infections parasitaires opportunistes citées.

05 Complications, cancers et risque cardiovasculaire

5.1. Pourquoi le VIH augmente-t-il certains risques ?

La destruction des CD4 et l'activation inflammatoire liée à l'infection peuvent contribuer à un risque accru de certaines tumeurs et de complications cardiovasculaires. La prise en charge ne se limite donc pas à rechercher une infection opportuniste : elle comprend aussi une prévention et un suivi des comorbidités.

5.2. Les cancers illustrés dans le cours

Complication	Élément pédagogique
Maladie de Kaposi	Liée à HHV-8 ; lésions ou nodules cutanés violacés sur les images de cours.
Lymphomes	Risque augmenté en contexte d'immunodépression.
Cancers liés au HPV	Le cours évoque notamment les cancers du col utérin et les cancers de la région anale/rectale. Nécessité de prévention et dépistages adaptés.
Risque cardiovasculaire	Importance des facteurs de risque et du suivi médical global.

À RETENIR

Un traitement efficace et un suivi régulier visent à prévenir à la fois les infections opportunistes, les complications de l'immunodépression et les autres risques de santé nécessitant une prévention personnalisée.

06 Dépistage, biologie et suivi

6.1. Dépister : ne pas attendre des symptômes

Le cours présente le dépistage sérologique VIH (la diapositive mentionne notamment l'antigène p24) et les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) ou autotests. Il souligne qu'un résultat rapide positif doit être confirmé par les examens de référence. Un résultat négatif très précoce après exposition ne suffit pas nécessairement à éliminer l'infection : le calendrier des examens est déterminé selon la situation clinique.

Prélèvements : repères du support officiel

La diapositive associe sérologie VIH / antigène p24 à un tube sec et charge virale VIH à un tube EDTA. Vérifier l'examen prescrit, l'identitovigilance et les exigences du laboratoire ; le repère de cours ne remplace pas ses consignes.

6.2. Le bilan d'une PVVIH

Examen / surveillance	Pourquoi ?
Charge virale plasmatique VIH	Quantifier l'ARN viral et évaluer la suppression de réplication sous traitement.
CD4	Mesurer la reconstitution immunitaire et apprécier le risque opportuniste.
Recherche d'IST/co-infections	Sérologies hépatites B et C, syphilis ; recherche chlamydia et gonocoque selon l'exposition.
Bilan de tolérance	Examen clinique et bilans prescrits (fonction rénale, hépatique, numération, etc.) selon le traitement.
Prévention / suivi	Statut vaccinal, dépistages ciblés et risques cardiovasculaires, gynécologiques ou proctologiques.

La séance décrit un suivi régulier, souvent tous les six mois et parfois espacé sous contrôle médical. Ce rythme varie selon la situation ; il ne remplace pas l'organisation du service ni les prescriptions.

LIEN CLINIQUE ESSENTIEL

Charge virale = réplication du VIH ; CD4 = état immunitaire. Une charge virale indétectable est un objectif majeur, mais le contrôle de l'infection et le suivi de la personne nécessitent plus qu'un seul chiffre.

07 Antirétroviraux : objectifs et observance

7.1. Traiter dès que possible, puis durablement

L'enseignante insiste sur un traitement débuté dès que possible et poursuivi à vie dans le cadre habituel. Les antirétroviraux inhibent la réplication du virus, permettent de diminuer la charge virale, de restaurer les CD4 et de prévenir la transmission sexuelle lorsque la suppression virale est durable. Un arrêt non encadré peut entraîner un rebond viral et une perte de protection immunitaire.

7.2. Associations, adaptation et exemples

Les schémas comportent selon l'indication deux ou trois molécules, parfois réunies dans un comprimé quotidien. L'oral cite comme exemples Biktarvy, Dovato et Delstrigo. D'autres modalités existent, notamment des traitements injectables à administration espacée pour certaines personnes. Le nom commercial ne remplace jamais l'identification des molécules et la vérification de la prescription.

Exemples de compositions visibles sur la diapositive

Nom cité sur le support	Principes actifs indiqués
Biktarvy	Bictégravir + emtricitabine + ténofovir alafénamide.
Dovato	Dolutégravir + lamivudine.
Delstrigo	Doravirine + lamivudine + ténofovir disoproxil.
Truvada + Tivicay	Emtricitabine/ténofovir disoproxil + dolutégravir : association montrée sur la diapositive.

Ces associations sont ici des exemples d'identification pharmaceutique du support, et non des recommandations de prescription ou de substitution.

Facteur de décision	Conséquence pour la prise en charge
Grossesse / projet de grossesse	Choix d'un schéma compatible avec le projet et suivi renforcé.
Co-infection hépatite B	Tenir compte des molécules actives sur le VHB.
Comorbidités / tolérance	Adapter aux fonctions d'organes, aux effets indésirables et autres traitements.
Interactions / résistances	Vérifier les co-prescriptions et l'historique thérapeutique.
Observance / préférences	Soutenir une modalité réellement tenable pour la personne.
Immunodépression avancée	Prendre en compte les infections opportunistes et leurs traitements.

7.3. Le rôle infirmier face au traitement

- Vérifier la compréhension : pourquoi poursuivre le traitement même sans symptôme ?
- Repérer sans jugement les obstacles : effets indésirables, oubli, horaires, précarité, difficultés psychiques.
- Observer et tracer la tolérance, les symptômes nouveaux et les besoins d'orientation.
- Favoriser l'éducation thérapeutique et un suivi coordonné : médecin, pharmacie, IDE, acteurs sociaux et associations.

08 Prévention médicamenteuse : PrEP et PEP / TPE

8.1. PrEP : AVANT l'exposition

La prophylaxie pré-exposition (PrEP) s'adresse à des personnes sans infection VIH pouvant y être exposées. Elle utilise des antirétroviraux à visée préventive. Le cours présente ténofovir disoproxil/emtricitabine (exemple cité : Truvada), en prise continue ou à la demande dans les situations éligibles. Le choix du schéma et son suivi sont médicaux. La PrEP à la demande ne se transpose pas à toutes les expositions ou populations.

Deux modalités injectables doivent être distinguées : cabotégravir par voie intramusculaire, avec une phase initiale puis des injections tous les deux mois ; lénacapavir par voie sous-cutanée, avec injections semestrielles et initiation orale selon son information européenne. Une autorisation européenne ne prouve pas à elle seule l'accès ni le remboursement en France du lénacapavir.

PRIORITÉ ORALE : PROPOSER ET EXPLIQUER

La PrEP doit être connue des soignants et évoquée sans jugement lorsque le contexte d'exposition le justifie. Elle ne protège pas de toutes les autres IST : dépistages, prévention et suivi restent nécessaires. Ce n'est pas un vaccin.

8.2. PEP / TPE : APRÈS une exposition

Le traitement post-exposition (TPE, ou PEP) impose une évaluation médicale urgente. Selon la recommandation française HAS de juillet 2024 consultée, un TPE indiqué débute au plus tôt, idéalement dans les 4 heures, au plus tard dans les 48 heures ; sa durée est de 30 jours, kit de démarrage inclus. Le support de cours indique 72 heures et 28 jours : ces repères divergents ne constituent pas la règle clinique française retenue ici. Le bilan initial ne doit pas retarder la première prise d'un TPE indiqué.

Suivi après exposition : le calendrier est individualisé

Bilan initial puis contrôles adaptés à l'exposition, au TPE, au risque d'hépatites et à une éventuelle transition vers la PrEP. Le repère de six semaines cité dans la séance ne constitue pas un calendrier universel après TPE : respecter le protocole médical applicable.

PrEP	TPE / PEP
Avant une exposition possible.	Après une exposition potentiellement infectante.
Démarche anticipée, conseil et suivi.	Démarche urgente : évaluation médicale sans délai.
Schémas oraux ou injectables selon indication.	Schéma post-exposition prescrit pour une durée définie.
Dépistages réguliers VIH et autres IST.	Évaluation du risque, tests initiaux, contrôle et traçabilité.

8.3. Accident d'exposition au sang (AES)

Pour une piqûre, un contact muqueux ou une autre exposition professionnelle, l'infirmier suit immédiatement le protocole AES du service, consulte sans délai pour évaluation et TPE éventuel et réalise les démarches de déclaration d'accident du travail. La seule connaissance du statut VIH d'un patient ne suffit pas à qualifier toutes les situations ; le type d'exposition et la charge virale notamment sont pris en compte.

09 Grossesse, partenaire et allaitement

Une grossesse est envisageable avec le VIH contrôlé

Le cas pédagogique porte sur une femme vivant avec le VIH, sous traitement bien suivi, avec une charge virale indétectable, qui souhaite une grossesse. L'enseignante rejette l'idée d'une obligation générale de PMA : une conception naturelle peut être envisagée lorsque les conditions de contrôle viral et de suivi sont réunies. Dans les conditions de suppression virale durable, le VIH n'est pas transmis sexuellement au partenaire.

La prévention de la transmission parent-enfant exige un suivi obstétrical et infectiologique spécialisé, le maintien de la suppression virale et, selon la situation, une prophylaxie néonatale. La séance souligne la nécessité de vérifier la charge virale pendant la grossesse et la qualité de prise du traitement.

Allaitement : ne pas répondre par une interdiction automatique

L'enseignante explique que des possibilités d'allaitement peuvent être discutées au cas par cas, dans des situations sélectionnées, avec information et accompagnement rapproché de la mère et de l'enfant. L'allaitement ne doit donc pas être présenté comme libre de toute condition, ni comme systématiquement impossible. La décision relève de l'équipe spécialisée et des recommandations applicables. Sous contrôle viral optimal, le risque de transmission par l'allaitement est très faible, mais n'est pas nul. Le principe I = I pour les rapports sexuels ne s'étend pas à l'allaitement.

APPLICATION AU CAS CLINIQUE

Reformuler le projet parental sans stigmatiser, vérifier le suivi médical, expliquer le rôle de la charge virale indétectable, orienter vers l'équipe spécialisée et ne pas inventer une obligation de PMA ou une impossibilité systématique d'allaiter.

10 Rôle infirmier et approche globale

10.1. Précautions standard : des soins sans stigmatisation

La transmission VIH dépend d'une exposition à un liquide potentiellement infectant par une voie de pénétration pertinente. Un contact courant ou un simple examen clinique ne justifie pas de protections supplémentaires du seul fait qu'une personne vit avec le VIH. À l'inverse, les prélèvements et actes à risque biologique justifient les mesures usuelles de prévention et de protection, comme pour tout patient.

10.2. Éducation thérapeutique et santé globale

L'enseignante qualifie l'éducation thérapeutique de priorité de la prise en charge : comprendre le mécanisme, le traitement, les objectifs de charge virale, les risques d'arrêt et les possibilités de prévention aide la personne à devenir actrice de ses soins.

- Relation de confiance : employer « personne vivant avec le VIH » plutôt qu'une étiquette réductrice ; protéger la confidentialité.
- Observance : discuter difficultés et préférences sans injonctions ni culpabilisation.
- Dimension sociale : précarité, hébergement, accès aux soins et aides adaptées peuvent conditionner la continuité du traitement.
- Dimension psychologique : anxiété, isolement et stigmatisation justifient un soutien ou une orientation.
- Prévention : vaccination, dépistage des IST et autres maladies, information PrEP/TPE, suivi régulier.
- Coordination : articuler les rôles IDE, médecin, pharmacien, psychologue, médiateur de santé et associations.

POSTURE EXPLICITEMENT MISE EN AVANT

Ne pas moraliser la vie sexuelle. Face à une question inquiétante, transmettre les informations fiables, adaptées au moment, rassurer sans minimiser et renvoyer au médecin ce qui exige une évaluation ou une prescription. L'infirmier peut être le premier interlocuteur d'une personne anxieuse.

11 Situations cliniques et raisonnement de soins

Cas A — Personne anxieuse après un rapport non protégé

Situation : M. M. vient pour un dépistage d'IST après avoir appris qu'un partenaire vit avec le VIH. Il est très anxieux. Le cours demande ce qu'il faut lui dire et relève les réponses trop moralisatrices ou alarmantes.

Réflexe adapté	Raisonnement
Accueillir l'anxiété sans jugement	Respecter la personne ; ne pas commencer par une menace de décès ou une leçon de morale.
Clarifier date et nature de l'exposition	Évaluer rapidement avec le médecin la possibilité d'un TPE urgent.
Proposer l'évaluation et le dépistage	Ne pas présumer du diagnostic ; organiser les examens appropriés et leur calendrier.
Transmettre un message rassurant et exact	Aujourd'hui, des traitements efficaces permettent de vivre avec le VIH ; I = I sous contrôle viral durable.
Évoquer la prévention future	Préservatif, PrEP, dépistage et prévention des autres IST, selon les besoins et le consentement.

CORRECTION ORALE DU CAS

L'enseignante ne retient pas l'option consistant à expliquer d'emblée à ce patient, dont le diagnostic n'est pas établi, qu'il risque de mourir d'une infection opportuniste. C'est à la fois prématuré et anxiogène.

Cas B — Projet de grossesse chez une PVVIH contrôlée

Situation : Mme M. vit avec le VIH depuis trois ans, prend correctement son traitement et possède une charge virale indétectable. Elle souhaite une grossesse. Les propositions de la diapositive sur le risque automatique pour le partenaire, la PMA obligatoire, l'infection inévitable de l'enfant et l'interdiction absolue d'allaiter sont discutées comme fausses dans leur formulation générale.

L'explication attendue porte sur la suppression virale durable, la possibilité d'un projet parental, l'importance du suivi spécialisé, la prévention néonatale et une discussion encadrée de l'allaitement, jamais une assurance sans conditions.

Cas C — Huit expositions : corrigé pédagogique du support complet

Le support officiel fournit les réponses progressives à cet exercice. Le tableau restitue la correction finale et en précise les conditions. Toute exposition réelle requiert une évaluation médicale rapide ; le raisonnement dépend notamment de la voie, du délai et des informations sur la source.

Situation du cours	Correction du cas	Condition / raisonnement
Rapport protégé, partenaire de statut inconnu	Non	Dans l'hypothèse d'une protection effectivement maintenue, sans incident.
Rapport non protégé avec une PVVIH indétectable	Non	Suppression virale durablement documentée ; ne pas présumer du contrôle viral.

Situation du cours	Correction du cas	Condition / raisonnement
Piqûre avec une aiguille abandonnée dans une poubelle	Non	Pas de TPE VIH automatique dans ce cas ; soins locaux et évaluation restent nécessaires.
Partage de seringue lors d'un usage de drogue	Oui dans le cas	Évaluation urgente de l'exposition et de la source ; ce libellé simplifié ne dispense pas de préciser le contexte.
Sang d'une PVVIH non contrôlée sur peau saine	Non	La peau doit être réellement intacte ; distinguer peau lésée et muqueuse.
Piqûre avec aiguille creuse utilisée chez une PVVIH non contrôlée	Oui	Exposition percutanée au sang, à évaluer en urgence.
Piqûre : source sans sérologie VIH connue	Conditionnel	Sérologie source urgente. Si négative sans risque de primo-infection : pas de TPE. Ne pas retarder un TPE indiqué en attendant un résultat.
Rapport HSH non protégé avec partenaires inconnus, sans PrEP	Oui dans le cas	Réponse du scénario pédagogique ; préciser les pratiques et le contexte pour une exposition réelle.

Pourquoi la réponse « conditionnelle » reste nécessaire

La couleur orange du corrigé correspond à l'incertitude sur la source. Elle ne signifie ni « toujours traiter », ni « toujours attendre ». Le recueil des informations et la décision médicale se font dans l'urgence.

12 Synthèse générale — l'essentiel du cours

EN UNE MINUTE

VIH : rétrovirus persistant ciblant les CD4. Sa réplication se mesure par la charge virale ; les CD4 évaluent les défenses. Sans traitement : progression possible vers des infections opportunistes, certaines tumeurs et le stade sida. Avec traitement efficace : suppression virale durable, amélioration immunitaire, vie proche de la normale et I = I pour la transmission sexuelle.

- Transmission : principalement sexuelle en France, aussi sanguine et parent-enfant selon les circonstances.
- Primo-infection : asymptomatique ou syndrome pseudo-grippal ; diagnostic biologique nécessaire.
- Infections opportunistes : pneumocystose, tuberculose, toxoplasmose, cryptococcose, CMV, entre autres ; prévention liée à l'immunodépression.
- Biologie : sérologie de dépistage, TROD/autotest à confirmer en cas de positivité, CV et CD4 pour le suivi ; rechercher les co-infections.
- ARV : instaurés dès que possible et poursuivis durablement ; adaptation aux comorbidités, interactions, grossesse et observance.
- Prévention : PrEP avant exposition ; TPE/PEP urgent après exposition, selon évaluation médicale ; prévention des autres IST maintenue.
- Soins IDE : précautions standard, repérage des complications, éducation thérapeutique, confidentialité, lutte contre la stigmatisation et accompagnement social/psychologique.

REPÈRES DE CONTRÔLE

Repères : risque accru d'infections opportunistes si CD4 < 200/mm³ ; objectif biologique < 50 copies/mL cité dans le support ; primo-infection symptomatique possible vers 2–6 semaines. Pour le TPE, retenir la référence HAS française consultée : idéalement dans les 4 heures, au plus tard dans les 48 heures, pendant 30 jours si indiqué. Les 72 heures / 28 jours du cours sont signalés comme divergents. Ces repères ne sont pas une prescription autonome.

13 Pièges QCM / confusions à éviter

Confusion fréquente	Correction à connaître
VIH = sida	Le VIH est l'infection virale ; le sida désigne un stade avancé selon des critères précis.
CD4 = anticorps	Les CD4 sont des lymphocytes T ; les lymphocytes B contribuent à produire les anticorps.
Charge virale = nombre de CD4	CV : ARN viral ; CD4 : état de l'immunité. Ils sont complémentaires, non interchangeables.
Indétectable = virus éliminé	La suppression de l'ARN circulant ne supprime pas les réservoirs intégrés.
I = I = absence de toutes précautions	I = I concerne la transmission sexuelle sous suppression durable, pas l'abandon des précautions standard.
PrEP = PEP = vaccin	PrEP avant exposition ; PEP après exposition ; ce sont des stratégies médicamenteuses.
PrEP protège des autres IST	Prévention du VIH, mais poursuite du dépistage et de la prévention des autres IST.
CD4 < 200 = sida automatique	Repère de vulnérabilité ; le stade sida requiert une qualification clinique/immunologique.
Tuberculose = précautions gouttelettes	La tuberculose pulmonaire contagieuse appelle des précautions Air adaptées.
PVVIH = isolement social / EPI exceptionnels	Les soins courants restent habituels ; précautions standard selon le geste.
Grossesse ou allaitement toujours impossibles	Projet parental possible ; conduite discutée en équipe spécialisée avec suivi et prévention.
Un test précoce négatif suffit toujours	Le calendrier de dépistage dépend de l'exposition ; avis spécialisé et contrôle peuvent être nécessaires.
Les 72 h / 28 jours du cours sont la règle française	La HAS de juillet 2024 retient au plus tard 48 heures et 30 jours pour un TPE indiqué ; agir au plus tôt.
Six semaines après TPE convient à tous	Le calendrier dépend de l'exposition, des traitements et des risques associés.
I = I garantit un allaitement sans risque	I = I concerne la transmission sexuelle ; le risque résiduel de l'allaitement n'est pas nul.

14 Définitions et mots-clés

Ce lexique clôt la fiche. Les définitions sont rédigées en phrases courtes pour une lecture et une révision vocale.

Terme	Définition
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine ; rétrovirus responsable d'une infection chronique.
PVVIH	Personne vivant avec le VIH ; formulation non stigmatisante.
Rétrovirus	Virus utilisant une transcriptase inverse pour produire de l'ADN à partir de son ARN.
Transcriptase inverse	Enzyme permettant la rétrotranscription ARN viral → ADN.
Intégration	Insertion de l'ADN viral dans le génome d'une cellule infectée.
ADN proviral	Forme d'ADN du VIH intégrée dans des cellules, participant au réservoir viral.
Réservoir viral	Ensemble des cellules ou sites où persiste le VIH malgré le contrôle de la réplication.
Charge virale (CV)	Quantité d'ARN du VIH mesurée dans le sang ; repère de suivi du traitement.
Indétectable	Charge virale sous le seuil de détection défini par la méthode du laboratoire.
I = I	Indétectable égale intransmissible : pas de transmission sexuelle du VIH sous suppression virale durable.
Lymphocyte T CD4	Cellule immunitaire qui coordonne la défense et constitue une cible majeure du VIH.
Lymphocyte T CD8	Lymphocyte T notamment impliqué dans la destruction de cellules infectées.
Lymphocyte B	Cellule immunitaire pouvant se différencier en plasmocyte sécréteur d'anticorps.
Immunodépression	Diminution des capacités du système immunitaire à protéger l'organisme.
Sida	Syndrome d'immunodéficience acquise ; stade avancé de l'infection VIH selon des critères définis.
Infection opportuniste	Infection favorisée par une défense immunitaire insuffisante.
Primo-infection	Période initiale qui suit l'acquisition du VIH, avec forte réplication possible.
Latence clinique	Phase parfois peu symptomatique, malgré la persistance du VIH.
Sérologie VIH	Examen biologique de dépistage recherchant des marqueurs de l'infection.
TROD	Test rapide d'orientation diagnostique ; un résultat positif appelle une confirmation.
Antigène p24	Composant viral recherché par certains tests biologiques de dépistage du VIH.

Terme	Définition
Autotest	Test de dépistage réalisé par la personne elle-même, avec confirmation médicale si positif.
ARN viral	Matériel génétique du VIH mesuré notamment pour la charge virale.
Antirétroviral (ARV)	Médicament qui inhibe une étape de la multiplication du VIH.
Bithérapie	Association de deux principes actifs antirétroviraux dans certains schémas.
Trithérapie	Association de trois principes actifs antirétroviraux.
Observance	Capacité et possibilité de suivre le traitement convenu dans la durée.
Co-infection	Présence simultanée d'une autre infection, par exemple une hépatite virale.
PrEP	Prophylaxie pré-exposition : prévention médicamenteuse avant un risque d'acquisition du VIH.
Cabotégravir	Antirétroviral utilisé notamment en PrEP injectable intramusculaire ; schéma initial puis injections espacées de deux mois.
Lénacapavir	Antirétroviral dont la PrEP européenne associe initiation orale et injections sous-cutanées semestrielles ; accès français à vérifier.
PEP / TPE	Prophylaxie ou traitement post-exposition : stratégie urgente après exposition à risque.
AES	Accident d'exposition au sang ou à un liquide biologique potentiellement infectant.
Pneumocystose	Infection pulmonaire opportuniste due à un champignon.
Cotrimoxazole	Antibiotique associé à la prise en charge et à la prévention de certaines infections opportunistes citées.
Tuberculose	Infection à mycobactérie pouvant toucher les poumons et d'autres organes.
Précautions Air	Mesures destinées à prévenir une transmission infectieuse aérienne, notamment dans certaines tuberculoses.
Toxoplasmose	Infection parasitaire pouvant occasionner des atteintes cérébrales chez une personne immunodéprimée.
Cryptococcose	Infection fongique opportuniste pouvant provoquer une méningite.
CMV	Cytomégalovirus ; virus pouvant causer notamment rétinite ou colite en immunodépression.
Rétinite	Inflammation de la rétine, potentiellement grave pour la vision.
Maladie de Kaposi	Tumeur associée à HHV-8, pouvant se manifester par des lésions violacées.
HPV	Papillomavirus humains ; virus associés à certaines lésions et cancers.
HHV-8	Herpèsvirus humain de type 8, associé à la maladie de Kaposi.

Terme	Définition
PMA	Procréation médicalement assistée ; elle n'est pas systématiquement nécessaire pour une PVVIH contrôlée.
ETP	Éducation thérapeutique du patient, visant compréhension et autonomie en santé.
HSH	Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ; terme de santé publique relatif à une pratique.
IST	Infection sexuellement transmissible ; nécessite prévention et dépistage adaptés.
Polyadénopathie	Augmentation de volume de plusieurs groupes ganglionnaires.
Cytolyse hépatique	Souffrance ou destruction des cellules du foie visible sur certaines analyses.
Dyspnée	Difficulté respiratoire ressentie par une personne.
Syndrome mononucléosique	Ensemble de manifestations cliniques et biologiques pouvant évoquer une mononucléose.